

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 22/02/2026 12:40

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Glicemia

DESCRIÇÃO:

njmk

RESULTADO:

****Relatório de Análise Médica****

****Nome do Paciente:**** xavier Tchivela

****Idade:**** 24 anos

****Gênero:**** Masculino

****Tipo de Exame Informado:**** Glicemia (Nota: Inconsistente com a imagem fornecida, que é uma microscopia de sedimento urinário.)

****Urgência Informada:**** NORMAL

****1. Descrição da Imagem e Qualidade Técnica****

A imagem apresentada corresponde a um campo microscópico de sedimento urinário, capturado com boa qualidade técnica. O foco é nítido, a iluminação é adequada e a magnificação utilizada parece ser apropriada para a identificação de elementos figurados na urina (provavelmente campo de grande aumento - CGA). Há uma homogeneidade na distribuição dos elementos visíveis. É importante salientar que, apesar de o contexto clínico indicar "Glicemia" como tipo de exame, a imagem é claramente uma análise microscópica de urina.

****2. Achados Principais****

A análise microscópica revela:

* ****Cristais de Fosfato Triplo (Estruvita):**** Presença abundante de cristais característicos de fosfato triplo (fosfato amônio-magnésiano), que se apresentam predominantemente com morfologia retangular, prismática, frequentemente descritos como "tampas de caixa". Estes cristais são proeminentes em todo o campo visual.

* ****Outras Partículas:**** Observam-se também inúmeras partículas menores e arredondadas, que podem ser hemácias, pequenas células epiteliais ou debris amorfos, mas em menor destaque e quantidade comparadas aos cristais de fosfato triplo.

****3. Diagnóstico Sugerido****

Com base na análise da imagem:

* ****Cristalúria por Fosfato Triplo (Estruvita) Massiva:**** A presença em grande quantidade desses cristais é o achado mais significativo.

* ****Considerações Etiológicas:**** Cristais de fosfato triplo são tipicamente encontrados em urina alcalina e são fortemente associados a Infecções do Trato Urinário (ITUs) causadas por bactérias produtoras de urease (por exemplo, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*). E...

[Diagnóstico completo disponível no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:****

No momento, não há indicação para a prescrição de medicamentos específicos (como antibióticos) antes da confirmação diagnóstica por exames complementares (urocultura). O tratamento será direcionado após a identificação do agente etiológico e seu perfil de sensibilidade.

****Recomendação de Suplementação (Hidratação):****

* ****Água potável:****

* ****Dosagem:**** Mínimo de 2,5 a 3 litros por dia.

* ****Frequência:**** Ingerir ao longo do dia, em pequenas porções, de forma contínua.

* ****Duração do tratamento:**** Contínua.

* ****Via de administração:**** Oral.

* ****Quantidade total a ser dispensada:**** Não aplicável (orientação de consumo).

* ****Observação:**** Aumentar a ingestão de líquidos é fundamental para promover a diluição urinária e

reduzir a concentração de substâncias formadoras de cristais, auxiliando na prevenção da formação e crescimento de cálculos.

* Caso seja identificada uma ITU, o tratamento adequado da infecção é o principal meio para normalizar o pH urinário. Qualquer intervenção para acidificação urinária deve ser cuidadosamente avaliada e orientada por um médico especialista (Urologista/Nefrologista), pois o uso inadequado pode ser prejudicial.

3. ****Investigação para Litíase Renal:****

* Devido ao risco aumentado de formação de cálculos renais de estruvita, recomenda-se a realização de exames de imagem, como:

* ****Ultrassonografia Renal e das Vias Urinárias:**** Para rastrear a presença de cálculos renais ou outras alterações anatômicas.

* ****Tomografia Computadorizada (TC) de Abdome e Pelve (sem contraste):**** Pode ser considerada para uma avaliação mais detalhada da presença, tamanho e localização de cálculos.

4. ****Dieta:****

* Não há recomendações dietéticas específicas que possam, por si só, reverter a cristalúria de estruvita sem o tratamento da causa subjacente. No entanto, uma dieta equilibrada e a manutenção da hidratação são sempre benéficas. Evitar dietas excessivamente ricas em vegetais pode ter um efeito marginal na alcalinização, mas o foco deve ser no tratamento da ITU.

5. ****Sinais de Alerta para Retornar ao Médico:****

* Febre (temperatura corporal elevada).

* Piora ou persistência da dor lombar ou abdominal.

* Dor ao urinar (disúria) intensa ou sangramento urinário visível (hematúria).

* Dificuldade ou incapacidade de urinar.

* Náuseas, vômitos ou calafrios.

6. ****Data para Retorno:****

* O paciente deve retornar ao consultório médico (preferencialmente Urologista ou Clínico Geral) com os resultados da uroanálise completa e da urocultura com antibiograma, para avaliação e planejamento do tratamento definitivo.

* Este relatório e as recomendações são baseados na interpretação da microscopia de sedimento urinário. A confirmação e o tratamento definitivo dependem da correlação clínica e dos resultados dos exames complementares solicitados.

* Não iniciar o uso de antibióticos sem orientação e prescrição médica, pois o uso inadequado pode levar à resistência bacteriana e dificultar o tratamento futuro.

* A hidratação adequada é uma medida importante e deve ser mantida.

* Dada a especialidade (Radiologia), este médico recomenda fortemente que o paciente seja avaliado por um ****Urologista**** ou ****Nefrologista**** para o manejo contínuo e tratamento da condição.

****Dr. Fernando****

Radiologista - CRM: sfgh

[Assinatura do Médico]

[Carimbo do Consultório/Instituição Médica]

[Endereço do Consultório]

[Telefone de Contato]

[E-mail (opcional)]

RECOMENDAÇÕES

****RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS:****

1. ****Esclarecimento e Confirmação Diagnóstica:****

* ****Uroanálise Completa (Sumário de Urina):**** Realizar ou revisar imediatamente, com foco no pH urinário, densidade, presença de leucócitos, eritrócitos, nitritos e proteínas. Um pH urinário >7.0, nitritos e/ou leucócitos reforçam a suspeita de ITU.

* ****Urocultura com Antibiograma:**** Imprescindível para identificar o agente bacteriano causador da infecção (se houver) e determinar o perfil de sensibilidade aos antibióticos. A terapia antibiótica será guiada por este resultado.

****OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:****

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: sfgh

radiologista

Receita gerada em 22/02/2026 12:40

ID da receita: 2

Sistema Médico - Receita eletrônica